Samedi 26: Infarctus Entéro Mésentérique

---

cas clinique

1. Énoncé clinique

- **Patient :** Homme de 78 ans.
- **Antécédents :** Fibrillation atriale non anticoagulée.
- **Histoire de la maladie :** Douleur abdominale brutale, intense, évoluant depuis 4 heures.
- **Examen clinique :** Abdomen souple, tension artérielle (TA) stable.
- **Biologie :** Lactate normal.

---

2. Questions et Réponses attendues

- **Question 1 :** Quel mécanisme est le plus probable ?
    - **Réponse :** Embolie de l'AMS (artère mésentérique supérieure).
- **Question 2 :** Quel examen demander en urgence ?
    - **Réponse :** Angioscanner artériel + veineux.
- **Question 3 :** Le lactate normal modifie-t-il la décision ?
    - **Réponse :** Non : il n'élimine pas une IMA (ischémie mésentérique aiguë) précoce.
- **Question 4 :** Quelle équipe prévenir ?
    - **Réponse :** Chirurgien viscéral, vasculaire, réanimateur, radiologue interventionnel.

---

3. Conclusion clé du cas

- **Conclusion :** Douleur brutale + FA = embolie mésentérique jusqu'à preuve du contraire.